



VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Presentazione riservata per family office e investitori privati · 2026 · "Venere" è un nome di lavoro

MISSIONE E VISIONE

Rendere la medicina estetica accessibile a tutti, nel proprio centro estetico di fiducia.

Portiamo la medicina dove le persone già vanno e di cui già si fidano: cura di sé normale, sicura e vicina. E la visione guarda oltre: rendere accessibile, un domani, anche la **chirurgia estetica del volto**, con una guida clinica di chirurgia maxillo-facciale già nel team.

Convertiamo i centri estetici in ambulatori di medicina estetica

Non partiamo dalle poche cliniche mediche in vendita (scarse, care, contese). Partiamo dai centri estetici: una platea enorme ed economica, con clientela e footfall già attivi, e ci aggiungiamo la medicina estetica **autorizzata**. Due playbook industrializzati tolgono i colli di bottiglia che fermano tutti gli altri.

1 · Playbook autorizzazioni

In Lombardia i trattamenti core (iniettivi, laser medicali) richiedono l'**ambulatorio autorizzato**: è lo step lento e il vero filtro. Noi lo industrializziamo: convertibilità pre-deal, template di sede, partner regolatorio, relazioni con ATS e Comune. Da mesi bespoke a settimane ripetibili. Più è difficile, più è il nostro fossato.

2 · Medici condivisi

Un pool di medici che ruota part-time su più sedi (come già fa il nostro CMO). Un direttore sanitario ancora fino a 3 sedi, poi un DS per cluster: medicalizzi molte sedi con pochi medici, ogni sede subito profittevole senza medico full-time.

3 · La fiducia è già del centro

È la missione in pratica: portiamo la medicina dove il cliente si fida già. Fedele all'insegna, non a un medico: convertendo ereditiamo quella fiducia e una base clienti calda, e la dipendenza dal medico (rischio n.1) è disinnescata all'origine.

Il roll-up rotola davvero. Il centro estetico paga l'affitto con l'attività non medica mentre autorizzi e converti; il medico condiviso aggiunge margine alto a costo fisso basso; il playbook autorizzazioni replica sede dopo sede. Dove Kliniky e Faceland comprano cliniche mediche care, **noi convertiamo sedi economiche in ambulatori** con medici condivisi.

Un mercato grande, in accelerazione e frammentato, con la finestra ancora aperta

1,37M

procedure di medicina estetica in Italia nel 2024, **+81%** sull'anno prima. 7,3M di italiani trattati (17,6%)

~80%

delle procedure sono filler e iniettivi: proprio i trattamenti che richiedono l'**ambulatorio**

0

operatori che convertono i centri estetici in ambulatori: il fronte che apriamo noi (le cliniche sono già contese da 5+ fondi)

~43k

centri estetici in Italia; **~1.000-1.900 idonei** ad ambulatorio: la platea che convertiamo, ben oltre le poche cliniche in vendita

L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il capitale istituzionale arriverà anche in Italia: chi costruisce prima detta i prezzi.

Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano domanda ricorrente: rimodellamento e skin quality post-dimagrimento.

Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza successori: venditori motivati, aperti a earn-out e permanenza.

È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Il nostro ingresso è la coda lunga dei centri estetici (a sconto) da convertire in ambulatori: ogni trimestre di attesa alza i multipli.

Cinque forze convergono su questa finestra. Non dureranno.

Corsa sulle cliniche, fronte beauty aperto

Le cliniche le consolidano già più fondi (Klinicy verso 60 sedi, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Il fronte dei centri estetici da convertire è ancora libero, ma non per sempre.

Ondata di venditori adesso

Ricambio generazionale: titolari verso la pensione senza successori, aperti a earn-out e rollover. Vendono ora.

Domanda in accelerazione

L'onda GLP-1 crea domanda ricorrente (skin quality e rimodellamento post-dimagrimento) proprio in questi anni.

L'Europa ha dato il segnale

UK e Spagna già consolidate: il capitale arriverà anche qui. Chi costruisce prima diventa la piattaforma da comprare.

L'AI è matura adesso

Per la prima volta agenti e modelli reggono operations multi-sede e decision-support. Chi parte oggi AI-native accumula il dataset.

Queste forze non aspettano. Ogni trimestre di attesa alza i multipli d'acquisto, riduce i venditori disponibili e, poiché i dati compongono, regala a un altro il vantaggio informativo. Il primo che parte non compra solo cliniche: **compra il tempo**.

Il modello medspa ha già vinto negli USA: da 18 a 49 mld \$

Il medspa è beauty + medicina sotto lo stesso tetto: esattamente ciò che facciamo. In Italia non esiste ancora (beauty e medicina sono separati). Noi lo portiamo convertendo i centri estetici in ambulatori.

Il mercato (è il nostro modello)

- ◆ Mercato USA oltre 18 mld \$ (2024) verso 49 mld \$ (2030), +15%/anno
- ◆ 10.000+ sedi frammentate: terreno da consolidare
- ◆ Le piattaforme con MSO e membership oltre il 40% valgono 10-13x EBITDA
- ◆ Lo stesso salto in Italia l'hanno già fatto dentale (DentalPro) e farmacie (Hippocrates)

I roll-up che lo provano

- ◆ LaserAway (Ares): da 74 a 219 sedi in 5 anni, ~150M\$ EBITDA, in vendita oltre 2 mld \$
- ◆ Milan Laser (Leonard Green), SkinSpirit (KKR), Ideal Image (L Catterton)
- ◆ Vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

Due motori: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato

Acquisto · 3-4x

Centri estetici a sconto: cassa e clientela già esistenti.



Medicalizzazione · +30-50%

Converti in ambulatorio e aggiungi la medicina (medici condivisi) + recurring, mix, saturazione, procurement.



Piattaforma · 7-10x

Catena nazionale con recurring ~30%, brand e management.

Compriamo centri estetici che generano già cassa (clientela fedele all'insegna, footfall reale) e li convertiamo in ambulatori con un format replicabile e due macchine: playbook autorizzazioni e medici condivisi. Anche senza espansione dei multipli, la crescita dell'EBITDA e la scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

Sei caratteristiche: cosa applichiamo a ogni centro convertito

Recurring su prescrizione

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

Multi-provider by design

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

Mix clinico completo

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

Patient journey da retail

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

Pagamenti rateali

Rateizzazione a tasso zero: rende la medicina accessibile, alza il ticket e apre la fascia 25-40.

Gestione manageriale

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.

La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso. Chi porta trasparenza cattura il re-rating, come nel dentale e nella diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme premium).

Rate = tracciabilità

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato. Formalizzi crescendo.

Rollover in equity

Il titolare reinveste parte del prezzo in una quota della piattaforma: trasforma reddito personale in capitale tassato e si allinea all'exit di gruppo.

Compliance = multiplo

Un asset pulito e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo, ed è il moat.

L'AI non è una promessa a 10 anni: crea valore su tre orizzonti

Oggi · margine

Agenti gestiscono agende, recall, pricing, procurement e KPI. HQ snello, integrazione più rapida, margini migliori da subito: il vantaggio operativo che uno studio da solo non ha.

Medio · qualità

Sul dataset reale del gruppo l'AI suggerisce piano e dosaggio, standardizza la qualità e riduce la dipendenza dal singolo medico (il rischio n.1). Il medico decide.

Lungo · costo

Il dataset di outcome è il substrato per l'automazione delle procedure standardizzate: attacca il costo e il collo di bottiglia dell'ora-medico.

Azienda AI-driven end-to-end (modello Bending Spoons). Lo stesso layer AI che fa girare le sedi guida la macchina di M&A: origination e scoring dei target, filtro di convertibilità autorizzativa, due diligence e integrazione a 100 giorni. Il dataset proprietario di outcome è ciò che la finanza da sola non compra: sposta la valutazione verso un multiplo AI-platform ed è il moat che rende difendibile il roll-up di questo team.

La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto

Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazione all'esercizio per struttura; medici condivisi tra sedi; area estetica non-medica separata dall'atto medico; piena autonomia clinica.

Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

Rete hub & spoke

Ambulatori **hub** (invasivo, alto margine, apertura al chirurgico) + studi medici **satellite** (non invasivo, consulenza, funnel a capex ridotto). Massima copertura, minimo capex per punto.

Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit.

Incentivi ≠ volumi

Mai bonus sul venduto: sicurezza e retention.

Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e consulenza.

Soglie reputazionali

KPI con blocco espansione al bisogno.

Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

Il target: centri estetici da convertire in ambulatorio

- ◆ Footfall e clientela già fedele all'insegna
- ◆ Ricavi tipici 0,4-1,5M; base clienti ampia e ripetibile
- ◆ Sede convertibile ad **ambulatorio**: ~90-120 mq, locali distinti, meglio indipendente (filtro pre-deal su destinazione d'uso e requisiti)
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster (Milano first, poi NO/NE)
- ◆ Titolare disponibile a permanenza + rollover

Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

Pipeline proprietaria. Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili e dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor di consolidamenti sanitari italiani. Il deal flow migliore non passa dai broker.

Dal format lab al primo operatore nazionale

Fase 1 · mesi 0-18

Format lab + prime conversioni in ambulatorio a Milano. Prova playbook autorizzazioni e tasso di conversione. Avvio raccolta dati.

Conversione provata, EBITDA/sede +30%

Fase 2 · mesi 18-36

Densità regionale: 8-12 sedi in 2-3 cluster (hub & spoke). Playbook 100 giorni, procurement pieno, brand, leva bancaria. Ingresso del Direttore Operativo dedicato.

10-16 sedi, recurring 20%+, EBITDA gruppo 1,5-2,5M

Fase 3 · mesi 36-60+

Scala nazionale ed exit: 20-30 sedi + dataset maturo. Target dei consolidatori PE / device-maker.

24+ sedi, EBITDA gruppo ~4M, exit 7-10x

Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).

L'economia di una conversione: centro estetico → ambulatorio

Centro estetico grande	All'acquisto	Convertito (24-36 mesi)
Ricavi	0,65M	1,20M
Margine EBITDA	15%	25%
EBITDA	~100k	~300k
Capitale investito	~700k (prezzo ~350k + capex ~350k)	

Numeri illustrativi da benchmark medspa, da validare in DD.

+ Medicina estetica in ambulatorio

- ◆ Medico condiviso part-time sulla base clienti esistente: iniettabili ed energy-based ad alto margine (medspa maturi 20-28%)
- ◆ Comprato ~**3,5x** (~350k): l'EBITDA reale è spesso sottostimato (contante, compenso del titolare), paghi sul normalizzato a sconto
- ◆ Capex conversione ambulatorio ~**350k** (autorizzazione, locali distinti, impianti, device). Il non-medico paga l'affitto durante la conversione
- ◆ **Ritorno:** ~300k EBITDA a regime; a multiplo medico 8x vale ~**2,4M**, MOIC ~**3,4x** per sede: doppio arbitraggio (sconto + re-rating)

Il consolidamento delle cliniche è affollato: il fronte dei centri estetici no

Operatore	Cosa consolidano	Backer	Beauty → medico	Dato + AI
Klinicy	Cliniche estetiche (verso 60 sedi entro il 2028)	Investitori	No	No
Vitaura	Cliniche estetiche e longevity	LIAN Group (LU)	No	No
Faceland · Juneco	Cliniche medico-estetiche	Verlinvest (BE)	No	No
Villa Brasini	Clinica estetica premium	Red Circle (R. Rosso)	No	No
Franchising (He Mediclinic, SkinMedic)	Poliambulatori in affiliazione	Parziale (non convertono)	No	No
VENERE	Centri estetici convertiti in ambulatori	Family office + debito	Sì · cuore	Sì · moat

Il consolidamento delle cliniche è già competitivo (Klinicy, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Venere apre il fronte inesplorato: acquisire i centri estetici e convertirli in ambulatori, con medici condivisi e moat AI/dati. **Nessuno lo fa.**

Visione, AI, clinica, operations: competenze complementari



Luca Martino

FOUNDER & CEO

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Visione, capitale, M&A, investitori.



Salvatore Diana

CHIEF AI OFFICER

Architetto della piattaforma agentica e del dataset proprietario: outcome tracking, AI decision-support e la roadmap verso l'automazione. Il moat che la finanza non compra.



Marcello Cammalleri

CHIEF MEDICAL OFFICER

Chirurgo specialista maxillo-facciale: anatomia del volto, protocolli e format clinico, direttore sanitario e reclutamento medici. Apre la strada alla chirurgia estetica del volto negli hub. Sotto il comitato scientifico indipendente.



Simona Cappello

COO · DIRETTORE OPERATIVO

Ingegnere e manager nella consulenza, con esperienza HR e formazione da psicologa. Operations multi-sede, persone, integrazione a 100 giorni e P&L per centro.

Contrappesi per costruzione: CFO e board seat dagli anchor investor; comitato scientifico indipendente sopra il CMO; advisor regolatorio-sanitario e fiscale-M&A. Il Direttore Operativo dedicato all'acquisizione entra in Fase 2, a modello provato.

Un asset che l'AI non erode ma potenzia, con un secondo atto oltre i 10 anni

Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il n.1 nazionale: la scala lavora a favore.

Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

Autorizzazioni (ambulatorio)

In Lombardia i trattamenti core richiedono l'ambulatorio: capex e tempi più alti. Filtro di convertibilità pre-deal (destinazione d'uso, ~90-120 mq, locali distinti) + playbook + advisor regolatorio. La barra alta è anche il nostro fossato.

Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

Conversione beauty → medico

Tasso provato su 1-2 sedi prima di scalare; il ricavo non-medico copre i costi durante la conversione.

Capitale e capex

L'ambulatorio richiede più capitale per sede: hub & spoke (pochi hub, molti satellite leggeri) e leva bancaria sui flussi contengono il fabbisogno.

Consolidatori concorrenti

Campo affollato sulle cliniche. La difesa: un fronte diverso (centri estetici) + velocità + moat dati. Chi ha già cluster diventa la piattaforma da comprare.

Il rischio n.1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.

Il seed prova, i KPI sbloccano la Series A

Non chiediamo una scommessa alla cieca. Il seed converte **un ambulatorio pilota**; tre KPI go/no-go dicono se scalare. La Series A scatta solo a semafori verdi.

1 · La domanda converte

≥ **12-15%** dei clienti esistenti prenota, **con caparra**.
Ricavi medici run-rate ≥ **€250k** a 9 mesi. La clientela beauty compra medicina estetica.

2 · L'autorizzazione regge

Capex di conversione ≤ **€400k** e apertura autorizzata ≤ **6 mesi**. L'iter ambulatorio è **replicabile**, non un one-off.

3 · L'economia torna

EBITDA a regime ≥ **€250k**, margine ≥ **22%**, **MOIC per sede ≥ 3x**. La singola unità rende come nel modello.

I tre verdi sono la **condizione della Series A**: il de-risking scritto. Il seed da €700k compra la certezza prima della scala, non la scommessa.

I round, in sequenza: proviamo, scaliamo, andiamo nazionali

Oggi · l'ask · €700k Seed

Il **primo centro con lettera d'intenti firmata** a Milano + pipeline qualificata (Marcello DS). Il seed avvia il **primo ambulatorio convertito (pilota)**: proviamo autorizzazioni, tempi ed EBITDA per sede. Check piccolo, rischio basso. La scala dei centri successivi è la Series A.

Pre-money €3,8M · post-money €4,5M · ~15% del capitale

A modello provato · €3-5M Series A

Densità del primo cluster (Milano + NO/NE): 8-12 sedi hub & spoke con playbook autorizzazioni, medici condivisi e macchina AI.

A densità provata · €10-15M Series B + debito

Scala nazionale: 20-30+ sedi, con leva bancaria sui flussi delle sedi già convertite.

Struttura: club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO dagli anchor), tranche legate a milestone. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x, con upside dal dataset. **Ti chiediamo ora il Seed da €700k a post-money €4,5M (~15%), con prelazione sui round successivi.**



Grazie.